

Datos Personales											
Nombre:	JUAN ANDRES ROMERO AHUMADA	Sexo Biológ.:	H	F. Nacimiento:	2017-11-04	Edad	8 Años, 2 Meses, Y 25 Días				
Identificación:	TI - 1067635905	Lateralidad:	Diestro	Estado Civil:	Soltero	Ocupación:	ESTUDIANTE				
Correo Electrónico:	Juana_irixx@hotmail.Com - 1067635905			Dirección:	Matias Boulevard Mz 2 Casa 13 Bosconia Cesar						
Departamento:	CESAR	Municipio:	VALLEDUPAR		Zona:	Urbana					
Empresa:	Particular										
En Caso De Emergencia Llamar A:		JUANA AHUMADA - Parentesco (madre) - Teléfono (3005058641)									

Apertura psicología del 2026-01-29 12:46:42: 8 años, 2 meses, y 25 días

DATOS GENERALES

Remisión

PARTICULAR

DX principal

NREF - NO REFIERE

DX Relacionado 1

NREF - NO REFIERE

DX Relacionado 2

NREF - NO REFIERE

Código de consulta

890208 - CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR PSICOLOGIA

Motivo de Consulta

Refiere la madre, “es un niño muy inteligente, pero no sé si es la etapa de rebeldía, me hace pregunta que no sé cómo responderle” “preguntas de la orientación sexual, de los papitos de por qué no están juntos” “presunción de acoso sexual de parte de un familiar mío” “dijo que había un sobrino que lo había intentado besar, que habían visto videos pornográficos de como chupar un pene, en una vez le dijo que se colocara encima de él, que una vez durmiendo había intentado poner su pene en la cola”.
Refiere el padre, “es celoso, no le gusta compartir sus cosas” “no deja que nadie se me acerque”.

Enfermedad Actual

Según refieren los padres, el niño presenta desde los cinco años cambios emoc

ANTECEDENTES

Natales

Tipo De Nacimiento Cesarea	Causa De La Cesárea Parto Estacional
Uso De Maniobras De Reanimación No	Peso Al Nacer 2800 (peso Actual 24kl)
Talla Al Nacer 54 (talla Actual 1.10)	Llanto Al Nacer Si

ANTECEDENTES

Posnatales

Hospitalizaciones Recién Nacido No Refiere
--

ANTECEDENTES

Desarrollo Psicomotor

Control Cefálico 2M	Rolado 3M
Sedente Solo 3M	Gateo 4M
Bípodo Sin Ayuda 9M	Marcha 10M
Lenguaje Verbal 6M	Lenguaje Verbal Fluido 12M

ANTECEDENTES

Médicos Familiares

Depresión No Refiere	Ansiedad Tío Materno
Demencia No Refiere	Alcoholismo No Refiere
Drogadicción Tío Paterno	Discapacidad Intelectual No Refiere
Patológicos Hipertensión, Diabetes, Cáncer De Hígado.	Otros No Refiere

Áreas de Ajuste y/o Desempeño

Historia educativa Actualmente el niño cursa tercero de primaria en el Colegio Happy Planet, ubicado en el municipio de Bosconia, Cesar. Según refieren los padres, presenta buen desempeño académico y adecuada adaptación al contexto escolar. Manifiesta mayor afinidad y rendimiento en áreas como Ciencias Sociales, Artística e Inglés, destacándose especialmente en actividades que implican exposición oral y participación activa. Aunque refiere menor preferencia por el área de Matemáticas, su desempeño académico en esta asignatura es adecuado. Se observa interés por el folclor y por participar en actividades culturales y extracurriculares del colegio. Asimismo, muestra curiosidad por temas relacionados con la política, acorde a su nivel de comprensión. En el ámbito social, los padres reportan buenas relaciones con sus compañeros, actitud colaboradora y disposición para participar en las dinámicas grupales del aula. Se reporta desarrollo temprano de habilidades de memorización, destacándose el aprendizaje de canciones desde el primer año de vida.
Historia laboral No aplica.
Historia familiar Actualmente el niño reside con su madre, la señora Juana Ahumada, de 28 años de edad. Mantiene vínculo y relación cercana con el padre, a través de visitas presenciales con una frecuencia aproximada de una a dos veces por mes. Según refiere la madre durante la

“yo quiero ser una niña”. Adicionalmente, la madre refiere que el niño compartió con una persona de confianza verbalizaciones relacionadas con orientación sexual, expresando “me identifico como bisexual”. Dichas manifestaciones se interpretan como parte de un proceso exploratorio propio del desarrollo infantil, sin que constituyan por sí mismas un motivo de consulta ni un indicador psicopatológico.

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

Evaluación psicológica inicial

Se realiza entrevista semiestructurada con la madre, el padre y el niño, con el objetivo de explorar los presuntos hechos referidos por la madre, el estado emocional, conductual y los relatos asociados a las situaciones referidas, así como identificar factores de riesgo asociados al comportamiento actual del paciente generaron malestar emocional y sensación de inseguridad y necesidades de intervención.

Relato materno: La madre refiere inquietudes relacionadas con conductas de celos, dificultad para compartir objetos y una marcada necesidad de exclusividad afectiva hacia el padre. Expresa preocupación por el impacto emocional que las situaciones familiares y los presuntos eventos relatados por el niño puedan estar generando.

Relato paterno: El padre describe al niño como celoso, con dificultad para tolerar que otras personas se acerquen a él, manifestando conductas de control afectivo.

Relato del niño (Individual a los padres): “paso una situación y por eso me trajeron aquí , un primo mío me decía, me engañaba diciendo no sé qué, un día me prestaron un celular, yo estaba entretenido ahí con un juego y luego el me mostro un teléfono y descargo el mismo juego que yo estaba jugando, e intento convencerme de irme con él a la habitación y me quiso subir encima de él, yo me agarre de la cama lo pateo y me fui como pude” “son dos hermanos uno tiene 15 y el otro como 16, y ambos me hacen juegos de tocarme el pipi” “también hay un primo mayor, o sea hermano de ellos que ha presenciado todo esto y no dice nada” “una vez que yo estaba dormido, el de 16 años se me puso atrás y me roso y yo sentí algo raro y me levante y él se fue haciéndose como que no había hecho nada, lo hizo sin bajarme el pantalón fue por encima” “también tiene un fetiche de agarrarle las orejas a la gente y yo no entiendo, eso es raro” “todo esto de la cama y el querer subirme encima de él paso en 3 días, cuando mi mamá me dejó en vacaciones allá” “pero de agarrarme el pipi y las orejas es siempre que voy lo hacen” “no le dije a mis papas porque pensé que me iban a regañar o pegar, entonces me sentía inseguro de decirles lo que me estaba pasando porque no tenía la suficiente confianza de decirles, también pensaba en que se iban a pelear y eso, entonces yo quería evitar problemas”.

PLAN DE INTERVENCIÓN

Plan de Intervención

Objetivo General

Brindar acompañamiento psicológico al paciente orientado a la contención emocional, el fortalecimiento de habilidades de afrontamiento, y la prevención de posibles afectaciones emocionales asociadas a factores psicosociales, favoreciendo su bienestar integral y su desarrollo emocional acorde a la edad.

Objetivos Específicos

- Favorecer la expresión emocional segura del niño mediante técnicas acordes a su etapa del desarrollo.
- Identificar y abordar respuestas emocionales y conductuales asociadas a situaciones familiares estresantes.
- Fortalecer la sensación de seguridad, confianza y validación emocional en el contexto familiar.
- Promover estrategias de regulación emocional ante frustración, celos y sentimientos de abandono.
- Acompañar a los cuidadores en el fortalecimiento de pautas de crianza protectoras y comunicación asertiva.

Sugerencias e Interconsultas

- Psicología Clínica (Terapia individual y Terapia Familiar)
- Pediatría o medicina legal, en caso de requerirse valoración médica complementaria según evolución del caso.
- Trabajo social / Comisaría de Familia o ICBF, para valoración y activación de rutas de protección, de considerarse pertinente.

Observaciones y Recomendaciones

OBSERVACIONES:

- El relato del menor se presenta de manera espontánea, coherente y consistente, lo cual amerita seguimiento clínico continuo.
- Al momento de la evaluación no se cuenta con confirmación médica ni legal, por lo que se mantiene el abordaje desde la observación clínica y prevención.
- El niño evidencia adecuadas capacidades cognitivas y comunicativas, con afectación principalmente en el área emocional.
- Se considera fundamental el acompañamiento familiar como factor protector del proceso terapéutico.

RECOMENDACIONES:

- Garantizar entornos seguros y supervisados durante el contacto con familiares y terceros.
- Evitar interrogatorios reiterativos al menor; permitir que el proceso se lleve desde el espacio terapéutico.
- Mantener rutinas estables, anticipación de cambios y validación emocional constante.
- Fortalecer la comunicación afectiva entre el niño y sus figuras parentales.
- Asistir a psicoeducación parental para manejo emocional y prevención de riesgos.
- Dar continuidad al proceso terapéutico y a las interconsultas sugeridas.

DRA. MARIA ISABEL PUMAREJO